



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : فاطمه كمال عبدربه ابراهيم
المحافظة : الجيزه
الحى / المدينة : امبابه
رقم البطاقة : 26211110100506 رقم التليفون : 01154874909
العنوان : ممممممممممممممممم
العمر(تاريخ الميلاد) : 11-11-1962 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستماره : 07-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / ----- / أ.د. / ----- / د. / ----- / د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----
قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: فاطمه كمال عبدربه ابراهيم National ID: 26211110100506	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

فاطمة
كمال عبدربه ابراهيم
٢٦ ش محمد عبدالقواب القراطين
مركز أوسيم - الجيزة

٢٦٢١١١١٠١٠٠٥٠٦

١٩٩٢/١١

LD4669410



Pathology Report

Patent Name	: 2621110100506
Patent No.	: 2824/22
Sex	: Female
Age	: 59 Y
Referring Doc	:
Request No.	: 13005439
Request Date	: 24/09/2022
Verification Date	: 10/10/2022
Financial Category	: 10/10/2022
Department	: Out Patient
Registered by	: marwa mohamed youss

CLINICAL DATA: Left breast cancer, post NACT.

NATURE OF SPECIMEN: LEFT Breast conservative surgery & Axillary lymph node dissection.

GROSS EXAMINATION:

- 1- LEFT Breast conservative surgery: Sector of mammary tissue measured 6x6cm with covering skin ellipse measured 2x1cm. Tumor extent: Serial cuts revealed an ill defined firm gritty greyish white tumour bed site.
- Size: measured 2.2x1.5 cm.
- Skin involvement: Unremarkable grossly.
- Distance from margins: 1cm away from least margin
- 2- Axillary lymph nodes dissection: fibrofatly tissue piece measured 5x6 cm entangling 12 lymph nodes up to 3x1 cm
- Frozen section: Free margins.

MICROSCOPIC EXAMINATION:

- Histological type: Invasive duct carcinoma (Cellularity 50%)
- Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): G II (3+2+1)
- Ductal carcinoma in situ: mostly solid type (15%).
- Angioinvasion: Inconspicuous.
- Perineural invasion: Inconspicuous.
- Skin involvement: Free.
- Resection margins: Free margins
- Lymph nodes: positive metastatic deposits in (2/12) with no extracapsular extension.
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response

DIAGNOSIS:

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 06/11/2022 12:12:23

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



Patient Name : **د. منى محمد علي** / **Dr. Mona Mohamed Ali**
Patient No. : 26211110100506
Path No. : 2824/22
Sex : Female
Age : 59 Y
Referring Doc :
Request No : 13005439
Request Date : 24/09/2022
Verification Date : 10/10/2022
Financial Category : **المرأة - فئة الجراحة**
Department : Out Patient
Registered by : **manwa mohamed youss**

Pathology Report

LEFT Breast conservative surgery & Axillary lymph node dissection:
Invasive duct carcinoma grade II with DCIS solid type (15%) with (50% tumour necrosis index).
• Free margins.
• Positive metastatic deposits in (2/12) lymph nodes.
• Pathologic partial response to therapy.
• Stage : ypT1, yp N1, yp Mx
• RCB : 3.931, RCB class III.

Prof. Dr. Lubna Omar

Verified by :
DR.Menna Nabil

Patient Name: Fatma Kamal Abd Rabbo	Date : 26/12/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 52 Year(s)
Medical ID: 4688/2021	Pat. ID: 12053

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST and abdomen and pelvis:

I-Chest Findings:

As compared to the last study dated 22/2/2024, The current revealed:

- Near total resolution of previously noted Right upper lobe posterior segment tree in bud appearance .
- Still noted left upper lobe and Lingular pleural based fine reticulations and atelectatic bands likely post radiazion ;
- *Otherwise*, Clear both lung fields
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- Near total resolution of Right upper lobe inflammatory process.

II-Abdomen and Pelvis Findings:

Compared to last CT study dated 23/08/2023.

- The liver is enlarged with homogeneous CT texture. Still noted unchanged right hepatic lobe segment VI subcentimetric hypodense millimetric focal lesion.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas and both supra-renal.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- The scanned skeleton shows stationary:



Dr. Wafid Mohamed, M.D.
Dr. doha ahmad

Patient Name: Fatma Kamal Abd Rabbo Ibrahim	
Exam : C.T CHEST	
Medical ID: 4688/2021	
Date : 26/12/2024	Age : 52 Year(s)
Pat. ID: 12053	

- Bilateral acetabular roof lytic lesions with sclerotic margins
- mostly benign degenerative.
- D4 tiny vertebrae body sclerotic lesion

Opinion:

- Rather stationary course since the last study.

Dr. Wafid Mohamed, M.D.

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
المركز الطبي التخصصي
دار السلام
قسم الأشعة

Patient Name: Fatma Kamal Abd Rabbo	Date : 05/09/2022
ibrahim	
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 50 Year(s)
Medical ID: 1849	

DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

Indication:

Post NACT status assessment of a known left breast cancer.

Report:

- ACR b: scattered fibro-glandular parenchyma of both breasts.
- Bilateral scattered calcific foci are noted.
- Left breast:

- UOQ irregular spiculated residual dense mass lesion with metallic clip. Ultrasound shows 2 o'clock irregular

hypoechoic mass, inseparable from the overlying skin

measures 2.7 x 2.3 cm compared to 3.4 x 2.6 cm.

- Regressive course of the previously reported left axillary

level I lymph nodes, the largest one measures 20 x 8 mm

and cortical thickness 5 mm compared to previous measures

26 x 7 mm with cortical thickness 8 mm.

- Right breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion

detected.

- Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.

- Normal skin thickness, and nipple-areola complex with

average caliber of the retro-areolar central ducts.

- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post NACT status of left breast showing partial response of the previously noted malignant mass with level I axillary lymph nodes (BIRADS 6).
- Right benign findings (BIRADS 2).

Best regards,
Dr. Wafaa Ali

Signature Temp

PM 2:52 2022/09/05

psychiatric	Nutrition	PATHOLOGY	RADIOLOGY	SURGERY	MEDICAL ONCOLOGY
SIGNATURE					

MDT OUTCOME & PLAN
 - Adx band at AI x 5
 - PPR1 to LPR R. 85C

Recommendations:
 was CRM → NACT 4AC → 4taxane
 → RCS & AIWD → y/Tx

Bx: Lf BCS + AIWD ER: 818 PR: 618 HER2: ve Ki67: ve	Sonomammography: IDC G II ERis - Free margins - Positive lymph nodes - (2/12) - pathological path - regressive
	Metastasis Workup:
	y P21 N1 M0

Clinical Data	
Name: 818 D 1590C MRN: C.51/2777 ID: 27C1111.1-0.7 Phone: 11320010.9	Co morbidity: Bronchial asthma BMI: 25.4 NRS SCORE: 2-9 Menopausal status: post marital status: 11320010.9 Family history: 11320010.9 REASON OF MDT: 11320010.9

MDT FORM 21/10/2022 6